

Asepsie et Hygiène

1 Introduction et Fondamentaux

1.1 Définitions essentielles

◆ Hygiène

Ensemble des mesures destinées à prévenir les infections et à maintenir la santé.
Elle englobe les comportements, les procédures et l'organisation environnementale.

◆ Asepsie

Ensemble des méthodes visant à empêcher l'introduction de micro-organismes dans un milieu stérile ou protégé.

➡ Objectif : **prévention**.

Exemple : désinfection d'un prisme avant tonométrie.

◆ Antisepsie

Utilisation d'un antiseptique sur des tissus vivants (peau, muqueuse) pour détruire ou inhiber les micro-organismes.

Exemple : povidone iodée avant injection intravitréenne.

◆ Désinfection

Élimination de la majorité des micro-organismes sur un support inerte.

◆ Stérilisation

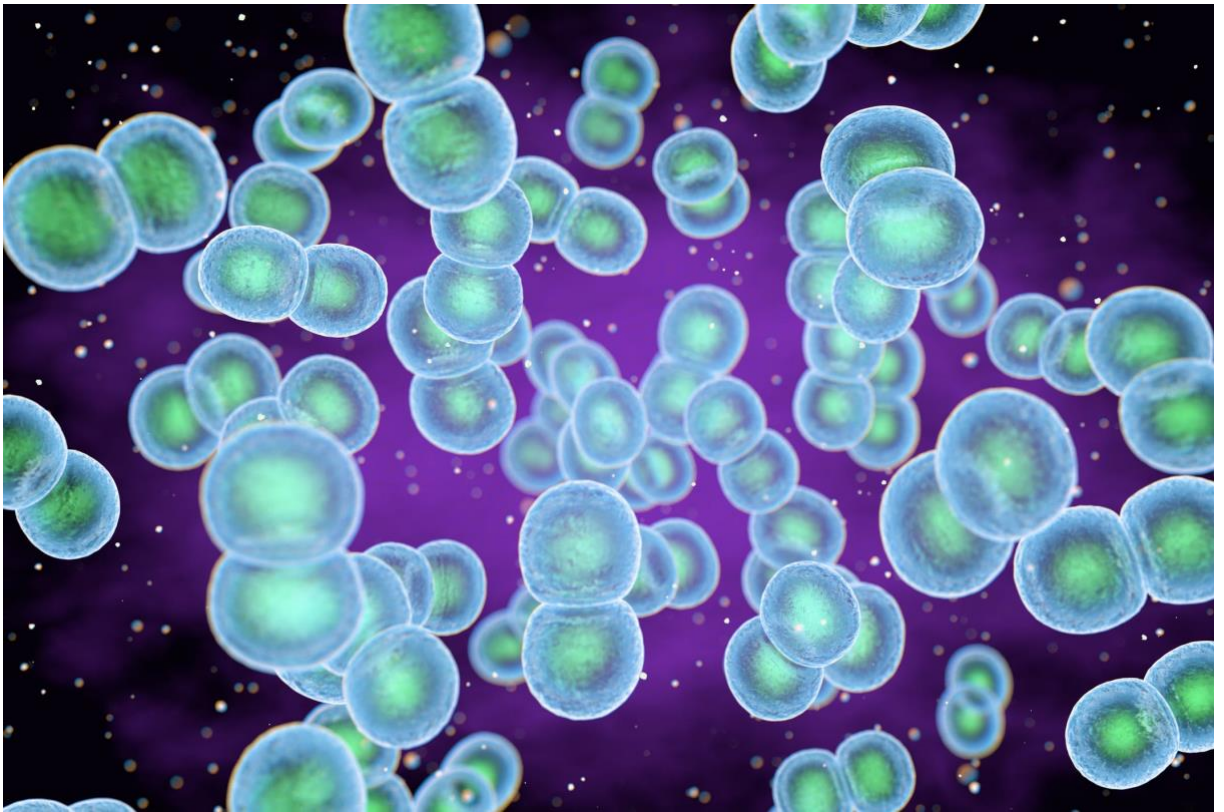
Procédé validé détruisant toute forme de vie microbienne (y compris spores).

1.2 Le microbiote oculaire et les agents pathogènes

◆ Microbiote oculaire

Flore résidente normale :

- Staphylocoques coagulase négative



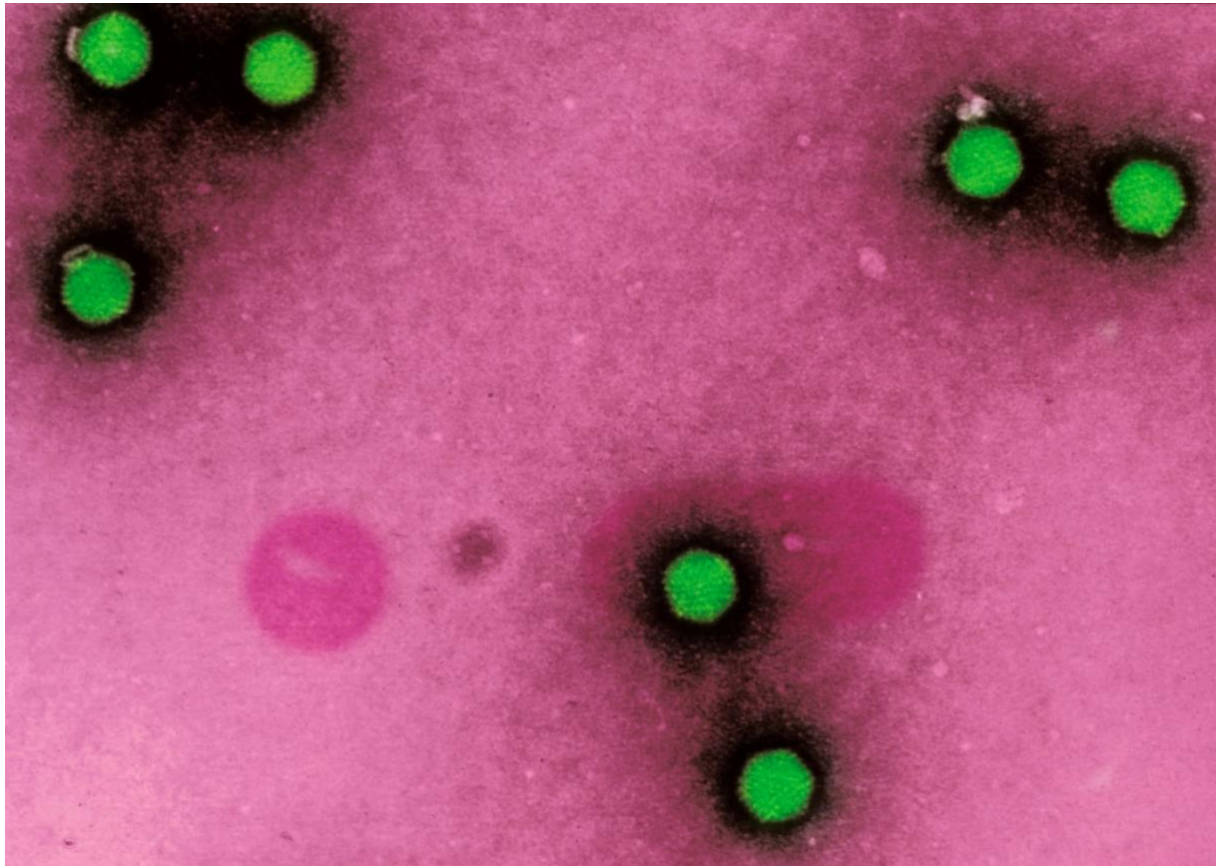
- Corynebacterium



◆ Pathogènes fréquents

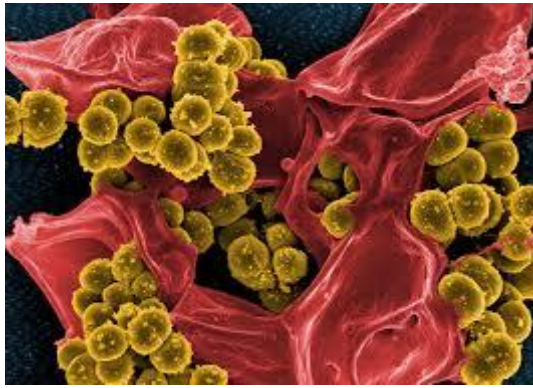
- **Adénovirus** → conjonctivites épidémiques

La conjonctivite est une inflammation de la membrane transparente (conjonctive) de l'œil, provoquant rougeur, démangeaisons, larmoiements et sécrétions (yeux collés). D'origine virale, bactérienne ou allergique, elle est souvent très contagieuse. Le traitement repose sur le lavage au sérum physiologique, avec des antibiotiques si nécessaire.



- **Staphylococcus aureus** → blépharites, abcès

La blépharite est une inflammation fréquente et souvent chronique du bord des paupières, se traduisant par des rougeurs, des démangeaisons, des brûlures, un œdème et parfois des squames (pellicules) à la base des cils.



- **Pseudomonas aeruginosa** → kératites graves (lentilles)

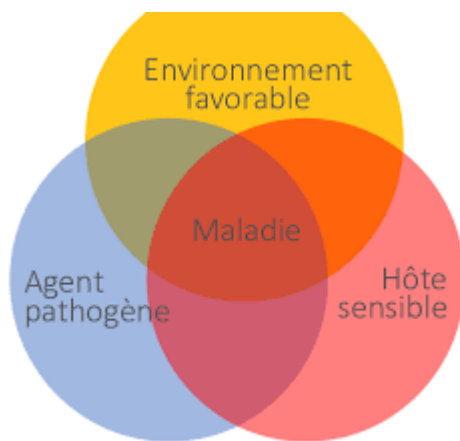


Les kératites infectieuses sont des infections graves de la cornée (bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires) nécessitant une prise en charge ophtalmologique d'urgence pour éviter des séquelles visuelles, voire la cécité. Le port de lentilles de contact, les traumatismes oculaires et les sécheresses sévères sont les principaux facteurs de risque.

1.3 La chaîne de l'infection

▲ Triangle épidémiologique

1. Agent infectieux
2. Hôte réceptif
3. Environnement favorable



🌀 Chaîne de transmission

Réservoir → Porte de sortie → Transmission → Porte d'entrée → Hôte



En ophtalmologie :

- Matériel mal désinfecté
- Mains du soignant
- Salle d'attente contaminée

2 L'Hygiène des Mains :

2.1 Flore résidente vs flore transitoire

Flore résidente	Flore transitoire
Permanente	Acquise par contact
Peu pathogène	Souvent pathogène
Difficile à éliminer	Éliminée par FHA

2.2 Les 5 indications OMS

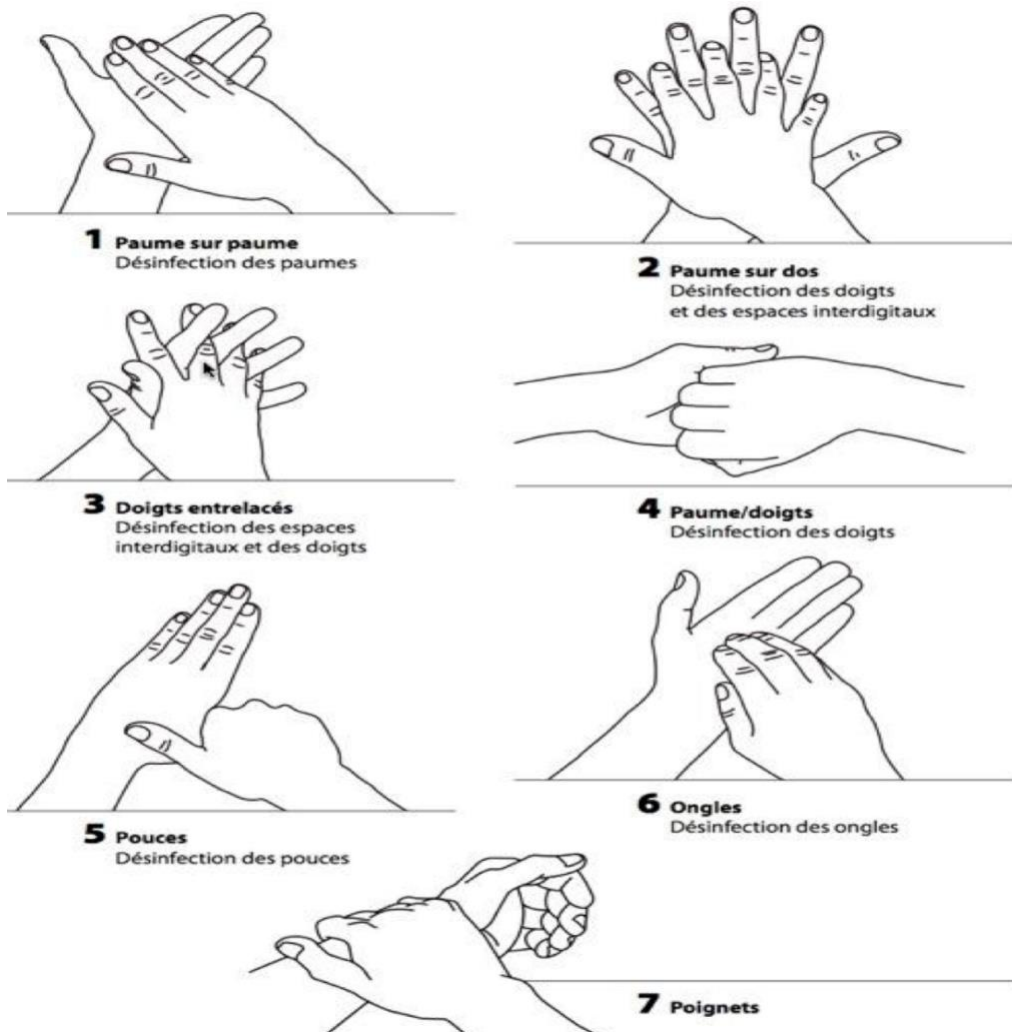
1. Avant contact patient
2. Avant geste aseptique
3. Après risque d'exposition biologique
4. Après contact patient
5. Après contact environnement patient

LAVAGE DES MAINS



2.3 Friction Hydro-Alcoolique (FHA)

- Durée : 20–30 secondes
- 7 étapes (paume, dos, espaces interdigitaux, pouces, pulpes...)



- ✓ Rapide
- ✓ Large spectre
- ✓ Moins irritant

3 Précautions Standard et Complémentaires

3.1 Précautions standard

Applicables à tout patient, quel que soit son statut infectieux.

◆ EPI (Équipement de Protection Individuelle.)

- Gants : si contact muqueuse/peau lésée
- Masque : symptômes respiratoires
- Lunettes : risque projection

3.2 Isolements complémentaires

Type	Exemple	Transmission
Contact	Conjonctivite bactérienne	Surface/mains
Gouttelettes	Adénovirus	Microgouttelettes
Air	Tuberculose oculaire	Aérienne

3.3 Accident d'exposition biologique

Projection oculaire :

1. Rinçage immédiat au sérum physiologique
2. Déclaration
3. Évaluation du risque viral
4. Suivi sérologique

4 Entretien de l'Environnement et du Matériel

4.1 Classification de Spaulding

Catégorie	Exemple	Niveau requis
Critique	Instrument chirurgical	Stérilisation
Semi-critique	Tonomètre	Désinfection haut niveau
Non critique	Monture d'essai	Désinfection intermédiaire

4.2 Zones à haut risque en ophtalmologie

- Mentonnière
- Appui-front

- Prisme de Goldman (utilisé sur les [tonomètres à aplanation](#) pour mesurer la pression intraoculaire (PIO))
 - Manettes
-

5.1 Risques spécifiques des lentilles

Kératite à *Pseudomonas* = urgence
Facteurs :

- Eau du robinet
 - Mauvais entretien boîtier
 - Port prolongé
-

5.2 Règles d'or à enseigner au patient

- ✓ Lavage mains avant manipulation
 - ✓ Jamais d'eau du robinet
 - ✓ Changer boîtier tous les 1–3 moi
 - ✓ Ne pas dormir avec lentilles (sauf indication)
-

6 Traçabilité et Réglementation

6.1 Responsabilité professionnelle

Responsabilité :

- Civile
- Pénale
- Disciplinaire

Un défaut d'hygiène peut constituer une faute professionnelle.

6.2 Traçabilité

- Registre de désinfection

- Protocoles écrits
 - Fiches de maintenance
-

7 Atelier Final (1h)

Simulation complète :

Accueil → Examen → Tonométrie → Instillation → Désinfection → Élimination déchets

Notation :

- Hygiène des mains
 - Port EPI
 - Désinfection du matériel
 - Traçabilité
-